EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 94249
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-10-06 12:57:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: CECILIA NICOLE LABRIN FALCON			RUN	: 19.823.354-4
F.Nac	: 28-10-1997	Edad	: 26 AÑOS, 11 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: GENERAL VENEGAS 1391			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA C	Teléfono	: 412687		
Fecha Ingreso	: 2024-10-01	Fecha Egreso	: 2024-10-06 12:57:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. B17.8-OTRAS HEPATITIS VIRALES AGUDAS ESPECIFICADAS

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. B15-B19-HEPATITIS VIRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente sin antecedentes mórbidos de importancia, refiere inicio de cuadro clinico el dia de hoy caracterizado por dolor abdominal tipo cólico de fuerte intensidad acompañado de deposiciones semiliquidas color marrón por lo cual acude a servicio de urgencias
Al interrogatorio dirigido hace 4 días presento cefalea y malestar general (primera consulta) indican analgesia y egresan (sintomas no fueron continuos)
Lab TGO/TGO 1203/1030 LDH 1337 GGT 542 Leuc 15500 Hb 12.6 Hto 36.7 Plaq 272000 ELP 138/3.70/105
Serología Hepatitis A, B y C negativas
TAC de abdomen y pelvis signos de hepatitis con edema periportal. Vesícula biliar con edema parietal difuso.
Pendiente AngioTAC de abdomen y pelvis
En sala se recibe en condiciones clínicas estables, afebril, hidratada, hemodinamia estable, Vigil, orientada en T E Y P
Ligera palidez cutaneo mucosa
Cardiopulmonar: MP+ sin agregados, RsCsRs NAS
Abdomen: blando, depresible, doloroso a la palpación profunda en forma difusa predominio HD, sin signos de irritación peritoneal . RH+
Extremidades: simétricas, sin edema ni signos de TVP
Evaluada por residente UTI quien indica ingreso en sala de medicina para estudio
Durante su estadia se procede a estudio etiologico de aptologia

TC AP: Signos sugerentes de hepatitis con edema periportal en ambos lobulos. Vesicula biliar colapsada, con edema parietal difuso y contenido hipodenso. Via biliar fina.
AngioTC: Estudio vascular sin alteraciones. Alteraciones descritas vesiculares pueden estar en contexto de Hepatitis aguda. Correlacionar con ex lab.
Eco abdominal: Engrosamiento parietal difuso 5.7mm, sin imagenes ecogénicas en su interior. Sugestivo de cambios sistémicos.
Se solicitan marcadores autoinmunes (ANA, AMA; ASMA, AntiLKM1, VHE, EB, CMV)
Evalñuado en conjunto con cirugia, quien descarta cuadro quirurgico actual, se decide continuar manejo de cuadro por medicina.
Paciente actualmente en perfil hepatico en franca mejoria
Examenes de lab 06/10 -> glicemia 85; crea 0,7; bili tot 1; GOT 116, GPT 285; GGT 269; lactato 0,6, PCR 10,3; Na/K/Cl 136/3.9/106; INR 1,05;
Paciente acualmente en buenas condiciones, con minima algia abdominal,m sin episodios de nauseas y/o vomitos, se decide continuar hospitalizacion via HODOm

PLAN DE MANEJO:

1)HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: estable, sin conflicto
3) GI: Con descenso de perfil hepatico, en vista de condiciones actuales, se decide continuar seguimiento de

perfil heaptico via HODOM y control poli medicina interna dentro de 21 dias (con resultados de examenes de derivacion)

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo semisentada 30°
2. Omeprazol 20 mg al dia VO por 5 dias
3. Metoclopramida 10 mg c/12 hrs VO por 5 dias
4. Control poli medicina interna dentro de 21 dias con resultado de examenes de derivacion
5. Perfil hepatico control dentro de 72 hrs

Control en: 21 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO